

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería



TÍTULO DE PROYECTO DE TESIS

**Percepción de riesgo de la Diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden a un
Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, 2024**

PROYECTO DE TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTOR

LEZAMETA ESTACIO, Gianella Deyna Verónica

ASESOR

Mg. Jhon Alex Zeladita Huaman

Lima, Perú

2024

Tabla de contenido

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN	3
I.1. Introducción	3
I.2. Planteamiento del problema	5
I.3. Objetivos	9
I.4. Importancia y alcance de la investigación	10
I.5. Limitaciones del estudio	11
CAPITULO II: REVISION DE LITERATURA	12
II.1. Antecedentes del estudio	12
II.2. Bases teóricas	16
II.2.1. Diabetes Mellitus	16
II.2.2. Percepción de Riesgo	22
II.2.3. PERCEPCIÓN DE RIESGO PARA LA DIABETES MELLITUS TIPO 2	25
II.2.4. Rol de Enfermería	28
II.3. Definición operacional de términos	31
CAPITULO III: VARIABLES	32
III.1. Variable	32
III.2. Operacionalización de las variables	32
CAPITULO IV: MATERIAL Y METODOS	35
IV.1. Tipo de estudio y método de investigación	35

IV2	Diseño de investigación	35
IV3	Sede de Estudio	35
IV4	Población	36
IV5	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	37
IV6	Procedimientos de recolección de datos	39
IV7	Análisis estadístico	39
IV8	Consideraciones éticas	40
CAPÍTULO V: ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA		41
V1	Cronograma de Gantt.	41
V2	Presupuesto.	42
V3	Recursos	42
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		43
ANEXOS		55
ANEXO 1: Formula de población finita		55
ANEXO 2: Matriz de consistencia del proyecto de investigación		56
ANEXO 3: Consentimiento Informado		58
ANEXO 4: Escala de Likert de Percepción de Riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2		59
ANEXO 5: Libro de códigos		62

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

I.1. Introducción

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica que se caracteriza por la resistencia a la insulina de los tejidos, lo que conlleva la elevación de la glucosa en sangre. Esta enfermedad es de causa multifactorial que afecta generalmente a los adultos maduros, en quienes se observa el desarrollo de las complicaciones de la enfermedad de manera prematura (1) (2). Los factores de riesgo pueden ser modificable y no modificables (3), de las cuales los factores de riesgo modificable (alimentación, actividad física, hábitos en la salud, etc.) son los de mayor importancia ya que los profesionales de enfermería pueden intervenir en Promoción de la salud y Prevención de las enfermedades, para ello se debe tener en cuenta el primer patrón de Marjory Gordon, Percepción de la Salud, pues estudios demuestran que las personas que perciben la enfermedad, la DM2, acatan medidas para prevenirla (4). La percepción según la psicología Gestalt es la base de los procesos cognitivos de cada individuo, siendo único y subjetivo, por lo que para poder abordar las necesidades de la persona es pertinente que se realice una valoración individualizada, pues los conocimientos, pensamientos o experiencias interfieren en la percepción de riesgo de la DM2 (5), lo que también intervendría en las actitudes y comportamientos para acatar medidas preventivas promocionales de la salud, ya que la percepción es la base de la actividad mental tales como la memoria, aprendizaje, pensamiento, etc.

La presente investigación tiene como objetivo determinar la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2023. Para ello se realizará un estudio de enfoque cuantitativo descriptivo de corte transversal; se utilizará Encuesta de Percepción de Riesgo para el Desarrollo de Diabetes (RPS-DD) medida en escala Likert que es válida para el idioma español e inglés (6).

El trabajo está compuesto por cinco capítulos, en el capítulo I se encuentra la introducción, donde se presenta el panorama de la investigación, seguido del planteamiento del problema que será indispensable para formular el problema, donde se observará a detalle los objetivos generales y específicos, así como la importancia y limitaciones de la presente investigación. El capítulo II está compuesta por la revisión de la literatura, antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas y la definición operacional de términos. En el capítulo III se presenta a la variable para luego presentar la operacionalización de la variable. El capítulo IV está compuesto por materiales y métodos que incluyen el tipo y método de estudio, el diseño de la investigación, sede del estudio, población, muestra y muestreo que contiene los criterios de inclusión y exclusión; también se presenta las técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis estadístico y las conclusiones éticas. Finalmente, el capítulo V se verá conformado por la adecuación administrativa que contiene el cronograma de Gantt, el presupuesto y los recursos que se utilizarán en el presente estudio.

I.2. Planteamiento del problema

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son aquellas que la persona padece fundamentalmente a causa de su estilo de vida, tales como la alimentación, actividad física, exposición al tabaco y/o alcohol, etc. Según la OMS las ENT son causantes de 41 millones de muertes al año, es decir el 71% de muertes, de las cuales 15 millones son en personas entre 30 y 69 años. Entre las enfermedades que ocasionan mayor mortalidad son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus (7).

La diabetes mellitus (DM) se caracteriza por los niveles de azúcar elevados en sangre, existen dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y tipo 2 (DM2) donde esta última se da por una alteración disfuncional en las células beta del páncreas (8) y abarca el 90% de diagnósticos entre ambos tipos (2). Según la OMS (2) 2000 y 2016, la mortalidad temprana por diabetes se incrementó en un 5% y en el 2019 la diabetes fue la novena causa de muerte más importante con 1,5 millones de fallecimientos, a su vez la incidencia hasta el 2019 es de 2 personas por cada 100 anualmente (9). Según ENDES 2022 el 5,1% de la población mayor de 15 años alguna vez ha sido diagnosticada por un médico de Diabetes mellitus, que en mayor proporción la DM2 abarca el 90% de estos diagnósticos. (10)

Los factores de riesgo de la DM2 son numerosos e incluyen: socioeconómicos, demográficos, ambientales y genéticos. Estos suelen clasificarse en factores no modificables y modificables, entre los primeros, Llorente, et al. (11), determinó que los antecedentes familiares son los principales, en Colombia, Rodríguez (3) encontró asociación significativa entre el riesgo de adquirir la enfermedad y el sexo femenino así como una edad por encima de los 45 años. Por otro lado entre los factores de riesgo modificables, prevenibles o tratables, están los estilos de vida no saludables, el déficit de actividad física o sedentarismo, fumar, bajo consumo de frutas y verduras, etc.; en relación con otras ENT, se tiene al

sobrepeso/obesidad, hipertensión arterial e hiperlipidemia; por último en el ámbito socioeconómico, el bajo nivel educativo y adquirir un salario inferior al mínimo. (3) (1) (12).

Según la Federación Internacional de Diabetes resume que los factores de riesgo que contribuyen a la incidencia de la enfermedad sería la urbanización, población que envejece, disminución de actividad física, aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad y todo lo que lleva a estas últimas mencionadas (13).

La DM2 tiene como complicaciones, a la pérdida de la visión, alteraciones de los riñones, enfermedades cardiovasculares, problemas cerebrales entre otros (14), si bien es inevitable que las personas con la enfermedad no tengan ninguna complicación, la aparición de estas puede retrasarse con adecuada adherencia al tratamiento, adquisición de conocimientos y prácticas prevenibles.

Los factores que determinan que una persona prevenga la DM2, son los conocimientos sobre sus factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad y la de sus complicaciones, pues los factores de riesgo innatos de una persona (antecedentes familiares) asociados a hábitos no saludables, lo llevarían a desencadenar la enfermedad (15). Sin embargo no solo es el conocimiento importante para prevenirla sino también la percepción de riesgo que tenga la persona, pues esta es un acercamiento a la realidad que ellos perciben, ello tiene relación según el primer patrón de la etapa de Valoración según Marjory Gordon (16), donde se resalta la relevancia de cómo el individuo percibe su estado de salud ya sea que esta esté alterada o no.

La percepción del riesgo de la diabetes se tiene gracias a los conocimientos previos, experiencias y punto de vista en base a su estilo de vida, estado de salud y entorno, pues es el conjunto de recepción e interpretación de cualquier estímulo sensorial del individuo y dependerá de si lo reconoce o distingue, para poder interpretarla en base a conocimientos

previos, contexto y emociones (17) (18). En la etapa de la adultez, estas características pueden determinar decisiones para poder adoptar recomendaciones, sugerencias o consejerías que se le puede brindar según el modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender, donde el profesional de enfermería tiene el deber de intervenir en el control de la salud, brindando conocimientos y fomentando comportamientos realizables para prevenir enfermedades (19) (20), o también en las intervenciones según la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, pues dependerá del nivel de autocuidado que tenga el paciente para aportar brindar conocimientos suficientes para ayudar al paciente a recuperar o mantener su autonomía (20).

Diversas investigaciones han abordado la percepción de riesgo de la Diabetes mellitus tipo 2. Un estudio realizado en Nápoles a padres de niños que asisten a escuelas públicas se obtuvo que de 527 padres el 97,3% han oído hablar de la diabetes, pero solo el 16,7% conoce los principales factores de riesgo y protección, la percepción de riesgo fue menor en personas con nivel de educación media o secundaria, en comparación con una percepción más acorde con aquellos que tenían título universitario o educación superior (21). En Cuba realizaron un estudio con el objetivo de determinar la percepción de riesgo de la diabetes mellitus en personas no diabéticas, donde se concluye que, de 1145 personas, el 59,2% de los participantes tuvieron percepción de riesgo, teniendo en cuenta que el 80,5 % de mujeres y el 78,5% de varones respondieron afirmativamente a la pregunta sobre obesidad y sobrepeso (22).

En Estados Unidos con el fin de explorar el conocimiento de la diabetes y la percepción del riesgo de enfermedad futura de los estudiantes universitarios, se hizo un estudio en 697 estudiantes, donde se tuvo como resultado que más el 90% percibió riesgo de diabetes como bajo o moderado, y los que se autoevaluaron como salud buena/excelente y leyeron las etiquetas de los alimentos regularmente a menudo tenían un menor riesgo futuro percibido de diabetes (23). Así mismo en otra investigación realizada en Nueva York, resaltan

que el riesgo percibido se correlaciona positivamente con el IMC, aunque en el mismo se halló que la percepción de riesgo de estudiantes con o sin antecedentes familiares, tienen el mismo nivel de percepción (24).

De estos hallazgos se puede afirmar que la percepción de riesgo de la DM2 es influenciada por experiencias personales, antecedentes y nivel de educación, sin embargo, se necesita más investigaciones que ayuden en la exploración de predictores de la percepción de riesgo del desarrollo de la enfermedad.

Los profesionales de enfermería son un ente importante en el primer nivel de atención, para promocionar un adecuado estilo de vida y prevenir enfermedades, entre ellos a la diabetes mellitus, según el nivel de prevención, pues en la historia natural de la enfermedad se aborda una protección específica y en la prevención secundaria, un diagnóstico oportuno (3), es por ello que la percepción orienta a poder implementar intervenciones oportunas en la promoción de la salud y prevención de la diabetes mellitus 2, ya que la percepción es la interpretación de todo el entorno tanto social cultural y ambiental (25).

En base a lo descrito, se recolectó información o comentarios de adultos del centro de salud Zárate. sobre qué es lo que perciben de la diabetes y dijeron: “es una enfermedad que puede ser genética pero depende de lo que uno come, así que hay que cuidarse” “yo creo que las personas que son gorditas tienen esa enfermedad porque luego bajan de peso rápido así que hay que cuidar el peso” “...de una amiga toda su familia de parte papá tenía diabetes, pero ella hasta ahora no tiene, lo que sí es que a veces sufre de la presión pero de ahí no tiene así que no es genético o a ella no le tocó, no sé mucho de la enfermedad pero eso es lo que puedo decir.”

De lo mencionado, las interrogantes serían: ¿Cómo perciben los usuarios del C.S. Zárate de la enfermedad Diabetes mellitus tipo 2? ¿Creerán que es importante saber los factores de riesgo? ¿Los conocimientos previos de la enfermedad habrán aportado en su

percepción de la enfermedad? ¿Será su percepción diferente de aquellos que tienen antecedentes familiares de los que no?

- **Formulación del problema**

¿Cuál es la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024?

I.3. Objetivos

- **Objetivo General:**

Determinar percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024

- **Objetivos Específicos:**

- Identificar percepción de riesgo en la dimensión control personal interno y externo que tienen los adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho
- Identificar percepción de riesgo en la dimensión preocupación que tienen los adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho
- Identificar percepción de riesgo en la dimensión sesgo optimista que tienen los adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho

I.4. Importancia y alcance de la investigación

La percepción de riesgo a desarrollar la DM2 es un factor o indicador importante en la toma de decisiones de los pacientes o usuarios, ya que es la vulnerabilidad que la persona percibe sobre su condición respecto a la enfermedad, lo que determina su comportamiento en la reducción del riesgo de desarrollar la enfermedad (26), es por ello los profesionales de la salud como primera línea en la prevención de las enfermedades y promoción de la salud deben de tomarlo en cuenta, ya que las personas no solo deben conocer sino involucrarse de manera significativa para que puedan aplicar recomendaciones a su propio estilo de vida, cultura y entorno ambiental, laboral y social. En ese sentido el estudio de este constructo proporcionará información sobre la percepción de riesgo de la DM2 en adultos maduros no diabéticos.

Existen escasos estudios en Latinoamérica acerca del tema, a pesar de que en esta Región existe entre un 8 y 13% de personas diabéticas y el 40% desconoce sobre la enfermedad, es decir, es un foco de incidencia y prevalencia de la enfermedad que cada año incrementa la tasa de morbilidad. Cabe recalcar que la prediabetes, que es un precedente a la DM2, tiene una prevalencia entre el 6% y 14% y está asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo que trae la necesidad de tratamientos, control y reforzar programas de salud pública para la concientización (27).

El Perú no es ajeno al déficit de estudios sobre este tema, a pesar de que se tiene que los peruanos de la zona urbana tienen 4,3 veces más riesgo de desarrollar la DM2 en comparación con los ciudadanos rurales (28). En ese sentido esta investigación es una contribución a los siguientes estudios en la profesión que tiene como fin la prevención de esta ENT.

Así mismo cabe recalcar que en el presente estudio se validará la Encuesta de Percepción de Riesgo para el Desarrollo de Diabetes (RPS-DD) (29) medida en escala Likert que es válida para el idioma español e inglés, para que sea accesible a las futuras investigaciones peruanas.

I.5. Limitaciones del estudio

Los escasos estudios tanto en el Perú como en Latinoamérica no permiten hacer una comparación relevante y actualizada de esta investigación con otras, por lo que se tuvo que tomar investigaciones de otros países, con culturas y estatus social diferente a la población de estudio, así mismo no se encontró una escala o instrumento validado en la población peruana.

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA

II.1. Antecedentes del estudio

Hsueh, et al. (30), realizaron un estudio en el 2019 cuyo título fue: “Percepción del riesgo de diabetes entre adultos inmigrantes y de minorías raciales/étnicas en los Estados Unidos”. Tuvo el objetivo de relacionar el estatus de inmigrante y racial/étnico con la percepción del riesgo de diabetes en una población sin diabetes de los Estados Unidos. Fue un estudio de corte transversal realizado en una muestra de 11569 personas no diabéticos y concluyen señalando:

“los extranjeros tenían menor riesgo percibido mientras que los mexicano-estadounidense, asiáticos y personas multirraciales se asoció a mayor riesgo percibido, lo que podría dar lugar a comportamientos preventivos deficientes por parte de los extranjeros y posterior detección de la diabetes” (30).

Pelullo Concetta, et al. (21), en Nápoles el 2019 realizaron un estudio titulado “Prevención de la diabetes: conocimientos y percepción de riesgo entre la población italiana”. Este estudio de corte transversal tuvo como objetivo determinar los conocimientos y percepción de riesgo de la diabetes en una muestra de 527 padres de niños que asisten a escuelas públicas. Se tuvo como conclusión

“El 97,3% ha oído hablar de la enfermedad y el 16,7% conoce los principales factores de riesgo. Respecto a la percepción, las mujeres mayores de 40 años con un IMC alto y con familiares diabéticos, tenían más probabilidades de percibir mayor riesgo de la enfermedad, así mismo las personas con educación secundaria tenían una percepción deficiente comparado con los que tenían educación superior” (21).

Angelina P. Nguyen (26) elaboró en el 2020 una investigación titulada “Percepción del riesgo de desarrollar diabetes: en análisis conceptual”. El objetivo de esta investigación fue analizar dimensiones del riesgo percibido de la diabetes, entre ellas la probabilidad percibida, el riesgo personal, el riesgo general, riesgo cognitivo, emocional, comparativo y optimismo poco realista. La investigación fue cualitativa y se utilizó análisis conceptual

mediante el enfoque de Walker y Avant, se seleccionaron 23 artículos. Las conclusiones de este estudio fueron:

“Los antecedentes del riesgo percibido eran factores motivacionales, diferencias particulares, el contexto, los conocimientos y factores afectivos. Una consecuencia de la percepción del riesgo de la DM2 fue la adopción de conductas que promueven la salud” (26).

Khan, Raihan et al. (23), elaboraron en Estados Unidos un estudio el 2020 que tiene el título de “Predictores de la percepción del riesgo de diabetes entre estudiantes universitarios”. Este estudio tuvo como objetivo determinar los conocimientos de la diabetes y la percepción de riesgo de esta, siendo los predictores de la percepción del riesgo los antecedentes familiares, conductas de salud personal y control percibido sobre los factores de riesgo. La muestra fue tomada por conveniencia y estuvo conformada por 697 estudiantes de una universidad estatal, del estudio se obtuvo como resultados:

“La mayoría percibieron que tenía bajo riesgo de desarrollar la enfermedad, así mismo que los que tenían mayor conocimiento de la enfermedad tenían más probabilidades de percibirse con mayor riesgo de desarrollar a futuro la diabetes” (23).

Koipuram et al. (31) en el 2020 realizaron una investigación que lleva por título “Conocimiento de la diabetes, percepción del riesgo y calidad de vida entre los cuidadores del sur de Asia en la edad adulta joven” con el objetivo de relacionar el conocimiento de la DM2, la calidad de vida, la percepción de riesgo y el riesgo real de desarrollar diabetes en adultos jóvenes del sur de Asia que tiene padres con DM2. El tipo de estudio fue cuantitativo descriptivo de corte transversal y tuvo como muestra 149 adultos jóvenes (76 mujeres y 73 varones), donde se obtuvo que

“el 32,5% de mujeres y 11% de varones participaron en la administración de insulina a sus padres; el 55,3% de mujeres y el 17,8% de varones manejaron complicaciones como heridas, niveles de glucosa bajo, daño nervioso entre otros. El 20,5% de los varones y 34,2% de mujeres tenían una alta percepción de riesgo, sin

embargo, los varones son los que tenían mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.” (31).

Sulaimán et al. (32) en la investigación realizada en el 2020 “Percepción de riesgo y conocimiento sobre diabetes en hijos de diabéticos tipo 2 en una institución de tercer nivel” tuvieron el objetivo de determinar el riesgo percibido de desarrollar DM2 y su conocimiento entre los hijos de pacientes diabéticos. La muestra estuvo constituida por 336 estudiantes de pre y post grado de la Universiti Kebangsaan Malaysia en el 2018. El estudio es de corte transversal y tuvo como resultado que

“el 56,5% identificó de manera correcta el riesgo de desarrollar la enfermedad y el 52,7% tiene un conocimiento adecuado, así mismo los de sexo masculino tenían mejor percepción que las mujeres” (32).

Khlaifat, Ali M., et al. (33) realizaron un estudio exploratorio de corte transversal titulado “Encuesta transversal sobre el conocimiento, las percepciones de riesgo y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes universitarios en el sur de Jordania”. Esta tuvo como objetivo medir el conocimiento, la percepción del riesgo y la práctica de la diabetes en siete universidades del sur de Jordania. Para este estudio consideraron un total de tres mil participantes de las cuales al final se obtuvieron 2158 encuestas óptimas para análisis (1031 varones y 1127 mujeres), donde se concluye:

“El conocimiento fue deficiente en el 41,9%, la percepción fue moderada en 52,5% y en la práctica fue ligeramente superior en 61,9%. Los estudiantes sin antecedentes pero que cuidan a alguien con la enfermedad predijeron significativamente la percepción de riesgo de DM” (33).

Alzaben, Abeer S., et al. (34) realizaron la investigación de corte longitudinal entre el 2020 y 2021 en la Universidad Princesa Nourah bint Abdulrahman, Riad, Arabia Saudita titulada “La influencia de un programa de concientización sobre la diabetes en el conocimiento, percepción de riesgos y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes

universitarios”. Este tiene como objetivo comparar el conocimiento sobre la DM, la percepción de riesgo y las prácticas de salud antes y después de un programa de concientización. En el estudio participaron 558 estudiantes y se obtuvieron los siguientes resultados:

“Los conocimientos fueron significativamente más altos después del programa, igual que la puntuación de la práctica moderada, sin embargo, no se obtuvieron diferencias en la percepción de riesgo antes y después del programa.” (34).

Antwi, Janet, et al. (24) realizaron un estudio piloto titulado “Percepción y factores de riesgo de diabetes tipo 2 entre estudiantes que asisten a una universidad del norte del estado de Nueva York”. El objetivo de esta es generar datos preliminares sobre la percepción de la DM2 y determinar la prevalencia de los factores de riesgo entre los estudiantes. En esta investigación de corte transversal realizado en el 2020 participaron 44 estudiantes de donde se obtuvieron perfiles metabólicos, datos sociodemográficos y antropométricos, así como conocimientos sobre nutrición y seriedad y autoeficacia percibida. Las conclusiones fueron:

“Se obtuvo que casi el 30% de participantes percibía que no se sentían seguros de poder prevenir la enfermedad. La mayoría de los estudiantes con glucemia alta en ayunas alterada, percibieron bajo riesgo de desarrollar DM2, al igual que los estudiantes con y sin antecedentes familiares.” (24).

Jimenez, Karla, et al. (35) Realizaron un estudio que llevó por título “Percepción de riesgo socio ecológico para diabetes tipo 2 en adultos mexicanos”. Esta investigación descriptiva transversal tuvo como muestra 268 adultos entre 18 a 59 años. Se obtuvieron como resultados de percepción alta en un 29.1% y percepción moderada en 59.3% y se concluyó que:

“Usualmente se analiza a la percepción de manera individual sin tener en cuenta factores de riesgo social y contextual, que son importantes ya que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Dicho esto, los mexicanos presentan una percepción de riesgo moderada.”

De los antecedentes mencionados se espera que, según el grupo etario o ascendencia racial se tenga una percepción variable, ya que como se menciona en la investigación de Hsueh, et al. (30), personas multirraciales y con ascendencia mexicoestadounidense, tienen mayor percepción, por lo tanto teniendo en cuenta el Perú es un país multicultural y multirracial, se esperan diversos niveles de percepción. De igual manera, encontramos en el presente constructo, de acuerdo con Pelullo Concetta, et al. (21), Khlaifat, Ali M., et al. (33) y Khan, Raihan et al. (23) es que el nivel de la percepción de riesgo esté determinada por el nivel educativo, edad y el haber tenido antecedentes familiares. Siendo esta última resaltado por Koipuram et al. (31) y Sulaimán et al. (32), ya que mencionaron que el tener antecedentes familiares implica el cuidado y por lo tanto el conocimiento empírico, en consecuencia la percepción más alta, esto es afirmado por la investigación de Alzaben, Abeer S., et al. (34), ya que realizan programas teóricos y si bien elevaron los conocimientos y prácticas, la percepción se mantuvo igual antes y después de las intervenciones. La presente investigación describe los resultados de la percepción de riesgo basándose en tres dimensiones, similares al de Angelina P. Nguyen (26), estas fueron probabilidad percibida, el riesgo personal, el riesgo general (Control personal interno y externo), riesgo cognitivo, emocional (preocupación) y optimismo poco realista (sesgo optimista), lo que afirma las particularidades y los factores que intervienen en la percepción. Antwi, Janet, et al. (24) resalta la importancia de medir el sesgo optimista, ya que en su población participaron personas con presentes factores de riesgos metabólicos, sociodemográficos y antropométricos, sin embargo obtuvieron niveles de percepción baja, lo cual afirma la relevancia de esta dimensión para determinar el nivel de percepción. Jimenez, Karla, et al. (35) abarcó una población similar, adultos entre 18 a 59 años, ya que se obtiene variedad de percepciones por el contexto, factores de riesgo sociales y el desarrollo individual por grupos de edad.

II.2. Bases teóricas

II.2.1. Diabetes Mellitus

La DM2 es una de las enfermedades no transmisibles más prevalentes en el Perú. Esta enfermedad se describe como un fallo o alteración de las células beta pancreáticas que se da por factores ambientales, genéticos, comportamentales y con una gran relación con comorbilidades como la obesidad y la hipertensión (35). Entre los signos más destacados está

la glucemia en sangre por encima de 126 mg/dL, siendo esta en realidad la posible causa de la resistencia a la insulina y un signo previo a la diabetes en sí (36).

A. **Fisiopatología:** El páncreas es un órgano mixto que produce hormonas y enzimas digestivas. Las células que producen hormonas son las alfa y beta, que producen glucagón e insulina respectivamente. Las células beta producen la insulina, para disminuir la glucosa en sangre ya que el glucagón que es producida por las células alfa se encarga de elevar la glucosa en sangre. La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica a causa de una continua disminución en las células beta del páncreas. Esta alteración llamada resistencia a la insulina ocurre por una hiperglucemia en sangre, esta puede darse por un consumo excesivo de glucosa presente en los alimentos y por un gasto energético deficiente, sin embargo, no se limita a ello ya que la causa es multifactorial. Para detectar la enfermedad se debe realizar una prueba de glucosa en sangre en ayunas y hallar los niveles de hemoglobina glicosilada. La enfermedad crónica puede ser controlada mediante medicamentos como metformina o la insulina inyectable, dependiendo del estado del paciente, es importante que se haga seguimiento a la adherencia ya que la enfermedad tiene complicaciones sistémicas que pueden retrasarse o evitarse con una adecuada adherencia (37) (38).

B. **Factores de riesgo:** Los factores de riesgo son situaciones o características que alteran el equilibrio del individuo, predisponiendo a una mayor probabilidad de padecer una enfermedad (39). Entre los factores de riesgo existen clasificaciones según los determinantes sociales y dos subdivisiones de acuerdo con la posibilidad de modificarlo o no, esta última siendo de interés ya que especifica en qué factores pueden intervenir el individuo, familia, comunidad y los profesionales de la salud para una adecuada atención primaria.

C.1. Factores no modificables

Edad: Esta enfermedad generalmente se desarrolla en adultos maduros (40 a 60 años) (40) (41) aunque no se descarta el riesgo en adultos mayores ya que el organismo envejece y las comorbilidades predisponen a la persona a que la enfermedad se desarrolle. Heredia y Gallegos (42) determinan que existe una relación entre el riesgo de adquirir diabetes y la edad, es decir a más edad, mayor riesgo de tener DM2 afirmando una relación directamente proporcional, así mismo describieron la relación indirecta entre el riesgo y el nivel de instrucción de los individuos.

Según la Federación Internacional de Diabetes 135, 6 millones de personas (19,3%) hasta el 2019 de entre 65 y 99 años tenían diabetes y se estima que serán 195,2 millones en 2030 y de 276,2 millones en 2045 en ese grupo etario (43).

Raza/Etnia: Los estudios revelan que las personas de raza blanca o caucásica tienen menor posibilidad a desarrollar la enfermedad que los de asiáticos, negros e hispanos, así como nativos americanos (44). Sin embargo, esta clasificación puede ser en parte influenciada por factores modificables, pues Bancks M. et al. (45) en un estudio en Estados Unidos, determina las asociaciones de factores biológicos, socioeconómicos, de vecindario y conductuales modificables en la edad adulta joven con la disparidad racial observada en la incidencia de diabetes entre individuos negros y blancos de mediana edad, se halló que si bien los individuos negros tenían más probabilidades de desarrollar DM2, esta dejó de ser significativa si se ajustaban los factores modificables de ambos grupos raciales. En el Perú la etnia mestiza tiende a tener mayor proporción entre los diagnosticados de la enfermedad. (10)

Antecedentes: Los individuos que tienen familiares de primer grado con DM2 tienen de 2 a 3 veces más riesgo de tener DM, así mismo aquellos que tienen padres o madres con DM2 tienen 5 a 6 veces más riesgo de tener DM2 (46) (47). Esta

información está relacionada con la susceptibilidad genética pues existe 3568 asociaciones de DM2 con expresión génica predicha en 687 genes nuevos (48). Por otro lado, aquellas mujeres que tuvieron diabetes mellitus gestacional (DMG), tiene mayor riesgo no solo de presentar DMG en su próximo embarazo, sino de desarrollar DM2 si la hemoglobina glicosilada (A1C) es mayor igual a 6,5%, así mismo, cabe resaltar que este valor no es saludable tanto para la madre y feto, ya que la hiperglicemia en el primer trimestre de embarazo está asociado a aborto espontáneo, anomalías congénitas o complicaciones en esta etapa. (49) En México, Chávez et al. (50) entrevistó a 5 mujeres que tuvieron mayor percepción de riesgo, antecedentes de DMG e interés en el control de esta. Tuvo como resultados que la mayoría de las mujeres definió correctamente la DMG así mismo tuvieron conocimiento sobre los factores predisponentes, mencionando a la alimentación, el sobrepeso y antecedentes de la enfermedad, de igual manera la percepción de riesgo por la presencia de DMG mencionaron el tener un hijo con sobrepeso, riesgo de desarrollar DM2 y DMG en embarazos futuros”

C.2. Factores modificables

Sobrepeso y Obesidad: Es la acumulación por encima de lo normal de tejido adiposo siendo perjudicial para la salud. Es de etiología multifactorial, de las cuales se resalta el estilo de vida y el desequilibrio de ingesta y gasto de energía (51). La alimentación es la ingesta de alimentos con la finalidad de satisfacer necesidades fisiológicas con los nutrientes que estos aportan. Sin embargo, existen alimentos que se deben consumir de manera limitada por los deficientes nutrientes o los excesivos macronutrientes que aportan, pudiendo desencadenar un desequilibrio energético en relación con el gasto que tenga el individuo, desencadenando sobrepeso u obesidad. El IMC es un indicador importante que determina el peso adecuado según la estatura

del individuo, Teufel et al. (52) afirman que “se observó un mayor riesgo de DM2 con un IMC mayor igual de 23 kg/m² , con un 43 % más de riesgo de diabetes para los hombres y un 41 % más de riesgo para las mujeres en comparación con un IMC entre 18,5 - 22,9 kg/m²” (53) Para ello se debe tener en cuenta que los refrescos o bebidas con azúcar se asocia a la obesidad infantil, lo cual está estrechamente relacionada a un desarrollo de la DM2 en la edad adulta (54), y un incremento de peso en adulto; por lo contrario, una dieta rica en fibra, verduras, granos, lácteos bajos en grasas y aceites como el de oliva o girasol, están asociados a un menor riesgo de desarrollar DM2 (47).

Hábitos de alimentación: El consumo de nutrientes es fundamental para un adecuado funcionamiento del organismo, además ayuda a conservar la salud y prevenir enfermedades por malnutrición. Una alimentación no balanceada pone al individuo en riesgo de tener ENT como la diabetes mellitus tipo 2 (55) (56). Estudios demuestran que los conocimientos y hábitos de alimentación saludable intervienen desde los primeros años de vida favoreciendo un desarrollo y crecimiento adecuado, además de prevenir el sobrepeso y la obesidad por tener un consumo y gasto de energía acorde el estilo de vida individual (57) (58). El consumo diario de alimentos que se recomienda para una dieta saludable para un adulto es consumir azúcares libres (azúcares agregados en bebidas o alimentos, miel, etc.) en menos del 5% del consumo calórico total, consumir sal por debajo de los 5g, consumir como mínimo 400g de frutas y hortalizas, menos del 30% de ingesta calórica debe provenir de las grasas de las cuales se debe ser preferiblemente grasas no saturadas presentes en la palta, pescados, frutos secos etc., así mismo la Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomienda un consumo diario de 20 a 35g de fibra, pues esta ayuda no solo a tener una mayor carga fecal sino a regular la glucosa en sangre mejorando la sensibilidad a

la insulina en el organismo (59) (55). Estudios recomiendan llevar una dieta balanceada ya que este es indispensable para poner en riesgo la salud de la persona, pues cuando el consumo de azúcares es elevado, la concentración de glucosa en sangre daña a las células beta del páncreas productoras de insulina, lo que lleva a un signo de DM2 (60).

Actividad física: Realizar actividad física es recomendable en todos los niveles de prevención, ya que previene enfermedades, trae sensación de bienestar general y reduce complicaciones de las enfermedades (61). Específicamente la relación de la realización de ejercicio y el riesgo de desarrollar DM2 es inversamente proporcional, ya que la actividad física disminuye glucosa en sangre, controla el peso y se asocia a equilibrio en el perfil lipídico en sangre (47) (62). Además que en estudios de España y Chile se afirma que el sedentarismo es un factor de riesgo importante (63) (40), pues personas con el mayor tiempo sentado y con obesidad tienen 3, 1 veces más riesgo de tener DM2 que personas con niveles bajos de tiempo sentado y un IMC normal (64). El tejido adiposo visceral es una característica del sobrepeso y obesidad, por lo que el perímetro abdominal superior de los 102 cm y 88 cm en varones y mujeres respectivamente no solo estaría relacionado con enfermedades cardiovasculares (65) sino también con una resistencia a la insulina, pues el exceso de ácidos grasos no esterificados, estimulado fundamentalmente por tejido adiposo abdominal, conduciría a una resistencia a la insulina (66) (67).

Hábito de Fumar: El hábito de fumar es la principal causa prevenible de enfermedades y de muerte, el dejar este hábito antes de los 50 años reduce a un 50% el riesgo de morir en los siguientes 15 años (68). Los fumadores se predisponen a tener valores elevados de glucosa en sangre, resistencia a la insulina y estar altamente relacionado con las complicaciones de la DM2 una vez tenga el diagnóstico (69).

II.2.2. Percepción de Riesgo

La percepción es el primer paso para el proceso cognitivo, es el conjunto de recepción e interpretación de cualquier estímulo que proviene de los sentidos, de tal manera que para cada individuo es diferente la identificación de cada fase. La recepción, se basa en cómo lo reconoce o distingue, la fase de interpretación se ve influenciada por conocimientos previos, contexto y emociones, es decir, cada individuo le dará su significación (17) (18). Según la psicología de la Gestalt, la percepción, es la base de la actividad mental tales como la memoria, aprendizaje, pensamiento, etc., pues estas dependen de la organización perceptual (70).

La existencia de una percepción sobre la salud depende del grupo etario, presencia de enfermedades y calidad de vida. Razo et al. (5) afirma que las personas en la edad adulta mayor con enfermedades tienen una mala percepción de salud además de una calidad de vida deficiente, en comparación con jóvenes sin enfermedades y una mejor calidad de vida.

La percepción de riesgo es una visión subjetiva de la vulnerabilidad de la salud frente a una enfermedad. Según las investigaciones si bien la percepción de riesgo percibido en la salud es subjetiva, derivan de un riesgo objetivo. Josianne Kollmann et. al. (71) realizaron una investigación con el objetivo de hallar una relación entre experiencia de riesgo y la percepción de riesgo, ya sea en riesgos agudos como ataques terroristas y riesgos de salud o acumulativos, como el consumo de alcohol, tabaco y alimentación poco saludable, en Israel y Alemania. Se obtuvo como resultados que se tiene una alta percepción de riesgo personal y social cuando hay una experiencia de terrorismo, sin embargo, la experiencia personal con riesgo acumulativo para la salud tiene relación con percepción de riesgo personal.

La asociación entre experiencias importantes, como crisis, accidentes, enfermedades, violencia y percepción de riesgo sirve para definir riesgos como los desastres naturales, delitos violentos, enfermedades, etc., por ello es importante tomar en cuenta a la percepción de riesgo percibido como un indicador para que el área de salud preventiva pueda buscar maneras óptimas de intervención, sin dejar de lado que existen factores que la influyen, como edad, género y educación en el tipo de percepción de riesgo que se desea estudiar (72).

A. Primer modelo de Percepción de Riesgo como indicador

Entre los primeros estudios que toman a la percepción de riesgo como indicador directo del riesgo de la persona y la influencia en las actitudes y comportamientos frente a la problemática, fue la investigación de Sander Van Der Linden.

La escala de Percepción de Riesgo del Cambio Climático (PRCC) se ha asociado con la predisposición de las personas a involucrarse en acciones que posibiliten la mejora favorable del cambio climático, apoyando políticas públicas con el mismo objetivo.

Van Der Linder en el 2014 (73) aplicó un instrumento compuesto por 8 ítems, una escala de Likert con 7 opciones dirigido a 808 sujetos de Reino Unido con el fin de explorar la relación causal entre la experiencia personal con eventos climáticos extremos, el afecto negativo y las percepciones de riesgo del cambio climático, donde se encontraron correlaciones significativas que indican que el efecto de la experiencia personal con eventos climáticos extremos está totalmente relacionado con la percepción de riesgo, en este estudio se concluyó, que la PRCC tiene como factores que explican alrededor del 70% variación significativa, a las experiencias, socioculturales y cognitivas.

Esta investigación dio paso a muchos autores a medir la percepción de riesgo y correlacionar con creencias, normas subjetivas y conductas en diferentes lugares del mundo (74), no dejando de lado al Perú en esta iniciativa (75). Tal es así que se le dio importancia a medir la percepción de riesgo no solo del medio ambiente sino de la salud, ya sea para medir percepción de riesgo de enfermedades infectocontagiosas o no transmisibles (76).

B. Modelos de percepción de riesgo para enfermedades no transmisibles (ENT)

Para poder medir la percepción de riesgo, se utilizan instrumentos tales como cuestionarios según indicadores, entrevistas y enunciados en primera persona con opción múltiple según escala de Likert. En el presente año, Molla Shumye (77) realizó un estudio transversal para relacionar y analizar la percepción de riesgo, el conocimiento y la intención de adoptar conductas preventivas para las enfermedades no transmisibles. Los resultados de esta investigación dan a conocer que la percepción alta de riesgo y una alta intención eran las principales características para adoptar medidas preventivas. La percepción de riesgo baja, reflejó un optimismo en la salud lo que facilita adoptar medidas de cambio.

En otro estudio (78) para medir la percepción de riesgo de Diabetes y enfermedades cardiovasculares, se tomó en cuenta factores de riesgo y percepción de factores de riesgo. Para determinar la relación se hizo un seguimiento de 5 años donde se obtuvieron datos como el IM y nivel de glucosa en sangre. El análisis consistió en determinar que las personas con IMC y glucosa en sangre elevados percibían riesgo en el futuro y predice cambios de estilo de vida para enfermedades crónicas, por lo que es de ayuda para que los entes de la salud busquen la manera óptima para intervenir en los comportamientos frente a enfermedades crónicas.

II.2.3. PERCEPCIÓN DE RIESGO PARA LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

A. Percepción de riesgo sobre los factores de riesgo de la DM2

En el estudio de Janett Antwi (24) se utiliza un instrumento que mide la percepción de riesgo de los factores de riesgo de la DM2, tomando en cuenta la división de factores de riesgo modificables y no modificables. Generalmente para evaluar las percepciones de riesgo se utiliza encuesta de Percepción de Riesgo Diabetes mellitus una escala de Likert modificada con enunciados afirmativos en primera persona. Los factores no modificables tienen relevancia por su comparación de la percepción de riesgo con datos demográficos y riesgos reales de la persona tales como antecedentes, edad, sexo y nivel educativo, que se hallan antes de responder el instrumento propiamente dicho.

B. Percepción de riesgo sobre complicaciones de la DM2

Una de las escalas que pueden ser utilizadas para determinar la percepción de riesgo de personas con la enfermedad, es la Escala de percepción de riesgo de agravamiento de la enfermedad, instrumento que mide los posibles motivos de agravamiento, el resultado grave, control de comportamientos y experiencia afectiva o emocional. Esta escala está compuesta por 40 ítems medida en Likert de 5 puntos (79).

La encuesta de Percepción de Riesgo Diabetes mellitus es utilizada no solo para determinar la PR de la enfermedad sino de las complicaciones, tal es así que Saglam y Bektas (80) se realizó un estudio a 330 pacientes con DM2 en el Hospital de la ciudad Eskisehir y se utilizó una Escala de Evaluación del Tratamiento de Insulina y la Encuesta de Percepción de Riesgo Diabetes Mellitus. Las conclusiones de este estudio dieron a conocer una percepción negativa alta de complicaciones en

insulinodependientes en comparación de otros diabéticos que reciben tratamiento con otros medicamentos.

C. Percepción de riesgo del desarrollo de la DM2

La percepción de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 es un indicador necesario ya que se relaciona directamente con los comportamientos para reducir el riesgo (26), además que estudios revelan que la percepción de riesgo refleja indicadores reales de riesgo. El instrumento más usado es la Encuesta de Percepción de Riesgo para el Desarrollo de Diabetes (RPS-DD) (29).

Para medir a esta variable existen dimensiones, entre ellas están identificadas a la probabilidad percibida, riesgo personal (control personal interno y externo), riesgo general, riesgo cognitivo, emocional (preocupación), comparativo y el sesgo optimista. Para el presente constructo se tomará en cuenta 4 factores medidas en 3 dimensiones.

C.1. Dimensiones e indicadores

- **Control personal interno y externo:** Diversos estudios en salud mental definen que el control personal refiere a las creencias que tiene el individuo sobre el desarrollo de una labor, alteración psicoemocional o enfermedades físicas, es decir si está en sus manos (control interno) o si está bajo control de las personas del exterior (control externo) (81) (82) , estos dos factores con dirección diferente, en el presente estudio están en la misma dimensión para determinar la percepción de quién o quiénes tienen el control del desarrollo de la enfermedad (DM2) en ellos mismos. Tal premisa se puede demostrar en que estudios anteriores se resalta que los hábitos alimentarios son los más percibidos, en lo que refiere los factores modificables, pues las personas relacionan y perciben que el comer ciertos alimentos en cantidades

desproporcionadas, así como no realizar actividades físicas acorde a su edad y estilo de vida, está directamente relacionado a desarrollar alguna enfermedad como la diabetes mellitus y que es la responsabilidad de cada uno (control interno) (53) (54) (56). Por otro lado, existen ciudadanos y poblaciones que responsabilizan el control de su salud al acceso de servicios de salud, a médicos o enfermeras y a la información que se les brinda o que adquieren de fuentes confiables, por lo que a pesar de que perciben el riesgo, su percepción de control externo es mayor que al interno, teniéndose un punto de análisis y valoración particular. Estudios como el de Khan Raihan, et al. (23), nos demuestra que aquellos que tienen más conocimientos, que pueden percibirlo como control interno o externo, se perciben con menos percepción de riesgo, así mismo definen sus probabilidades de riesgo en un futuro, por lo que es importante esta dimensión en el análisis de la percepción para entender actitudes futuras que puedan tomar las personas.

- **Preocupación:** En el ámbito de la salud, esta es una característica emocional frente a la posibilidad de desarrollar o no una enfermedad, es decir emoción frente a situaciones inciertas sobre la salud y bienestar físico, su presencia interfiere en las intenciones de adquirir conocimiento, ya que esta dimensión perceptual permite interiorizar subjetivamente la enfermedad, tal es así que Koipuram et al., destaca que en un grupo estudiado de personas, entre varones y mujeres, fueron en su mayoría las mujeres las que participaron en la administración de medicamentos y curación de heridas entre el manejo de otras complicaciones, lo cual dio como resultado que la percepción del desarrollo de la diabetes de las hijas era alta, aunque en realidad los varones tenían más factores de riesgo de desarrollar la enfermedad (31). De lo antes mencionado se infiere que la preocupación que tuvieron las hijas, es un indicador para adoptar medidas preventivas a partir de la autoconcienciación, ya que así se realicen

las prácticas y se conozca, ello no impacta en la adaptación e implementación de actividades preventivas tanto como la percepción. Rymon y Nowicka tomaron en cuenta a este indicador en su estudio en pacientes con DM1 y afirman que quienes perciben beneficio de su enfermedad, tienen puntajes significativamente altos en control personal y control de tratamiento, mientras que tienen puntajes de percepción baja en preocupación (83). Ello quiere decir que si el indicador de esta dimensión es resaltante, podría darse paso a una percepción de control interno o percepción de riesgo bajo.

- **Sesgo optimista:** Esta dimensión tiene la característica de determinar la percepción de un riesgo o no a desarrollar diabetes sin tener en cuenta el riesgo en sí mismo, es decir que se evidencia una actitud positiva o con pronóstico de bienestar subjetivo poco realista frente a otras personas. Antwi Janet, et al. (24), tuvo como resultado en su investigación que menos de la tercera parte percibía riesgo de desarrollar la DM2, y que, de la mayoría de sus participantes con glucemia alta en ayunas, tuvieron percepción baja. Es decir que, a pesar de los riesgos presentes, si ellos no lo perciben, dichos riesgos son inexistentes.

II.2.4. Rol de Enfermería

A. Enfermería y percepción de riesgo de la DM2

Los patrones funcionales de Marjory Gordon, son fundamentales para poder desarrollar actividades o intervenciones en enfermería, ya que denota interés holístico en la persona o familia, por lo que utilizar esta herramienta para el cuidado, evidencia una práctica aplicada en evidencia científica para determinar necesidades fisiológicas y psicológicas del paciente (84).

Es por ello por lo que Marjory Gordon en su primer patrón Percepción y manejo de la salud, que se toma en la etapa de valoración, busca determinar el

concepto o idea que tiene el paciente respecto a su salud en general, ya sea bienestar y enfermedad en ella (16).

La percepción de riesgo de la salud es la primera impresión en base a conocimientos e ideas previas sobre los factores de riesgo de una determinada enfermedad, esta puede determinar la participación o intervención de las personas en acciones o medidas preventivas para su propio estilo de vida (85).

B. Enfermería en la prevención de DM2

Las medidas preventivas son aquellas acciones que se toman para retrasar, disminuir o eliminar el riesgo de adquirir o desarrollar una enfermedad, modificando el estilo de vida, alimentación y hábitos del individuo, ya que estas son parte de los factores que pueden modificarse y controlar con un adecuado conocimiento y prácticas (86).

De manera fisiológica existe una elevación de glucosa en sangre a causa de las emociones fuertes ya sea por estrés, ansiedad o depresión, pues el cuerpo se prepara para enfrentar las situaciones, deja de producir insulina para proteger y ayudar a enfrentar estas situaciones, por lo que una mirada holística de prevención es fundamental, tomando en cuenta no solo aspectos físicos para prevenir sino psicoemocionales (87) (88). Este tema es de importancia para el peruano, ya que la incidencia y prevalencia de la DM2 está en incremento, tomándose en cuenta los factores de riesgo relacionados, el más alarmante es el estado de sobrepeso y obesidad en más de la mitad de adulto y un cuarto de población infantil, por lo que se necesitaría atención de profesionales en los niveles de prevención según la situación de la persona familia y comunidad (89).

A pesar de la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, no se tiene una adecuada medida preventiva en ninguno de los 3 niveles de prevención, de tal manera que pone en riesgo la calidad de vida del paciente (90).

Como profesionales de enfermería se apela a la Teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, donde se define autocuidado a las capacidades que el individuo tiene para cuidar de sí en su total integridad, de tal manera que mantenga su salud en equilibrio, pues esta se puede ver alterada por factores externos (económicos, socioculturales o ambientales) o internos (emocionales, alteraciones psicológicas o predisposiciones biológicas) que pondrá al individuo en una posición de necesidad del cuidado del profesional de enfermería. Esta teoría se puede aplicar para cualquier nivel de prevención, solo se debe determinar de manera apropiada el grado de autocuidado de la persona, es así que el profesional de enfermería aplicaría actividades de enseñanza, consejería, cuidado en necesidades básicas, aplicaciones de tratamientos, entre otros (91).

C. Enfermería en la promoción de la salud

El Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender es utilizado en el área de Enfermería para comprender los comportamientos de las personas respecto a la salud y tiene como finalidad promover actividades, para poder alcanzar prácticas saludables que mejoren la salud y bienestar de las personas, familias y comunidad, así mismo prevenir enfermedades, de tal manera que ellos tengan el control sobre sí mismos y se eliminen los riesgos que predisponen a diversas afecciones (92)

Para poder aplicar este modelo, diversos estudios e investigaciones realizan un plan de cuidado, capacitación, planes de intervención, etc., de tal manera que se observe y analice los resultados para contrastar el avance o diferencia de los métodos de intervención de enfermería con este modelo. (93) (94).

En torno a lo mencionado, este modelo es infalible en los planes de acción en el área de enfermería por lo que el objetivo es que las personas tengan el poder y la capacidad de aplicar métodos aptos para cada contexto y entorno socio – ambiental.

II.3. Definición operacional de términos

- Percepción de riesgo: Impresión subjetiva de un estímulo predisponente a un desequilibrio en la salud del individuo que se interpreta en base a conocimientos previos, ideas, pensamientos, etc.
- Adulto: En el Perú, el adulto tiene 3 sub etapas, el adulto joven (20 a 40 años), adulto maduro (40 a 60 años) y adulto mayor personas de 60 años a más edad.

CAPÍTULO III: VARIABLES

III.1. Variable

La Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2, es una variable de naturaleza cualitativa que en la investigación asumirá una posición cuantitativa, ya que será medido a través de tres dimensiones por una encuesta en escala de Likert, con un valor final de percepción baja, media o alta.

III.2. Operacionalización de las variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Indicadores/ Enunciados	Valor final	Definición operacional
Percepción de riesgo de la diabetes	Impresión y estimación subjetiva de un estímulo determinado que se interpreta en base a conocimientos previos, ideas, pensamientos, etc., acerca de los factores de riesgo, modificable y no modificables, de la enfermedad Diabetes Mellitus tipo 2.	Control personal (Interno y externo)	Creo que mis esfuerzos personales (ejem: ir al médico, priorizar mi salud, etc.) me ayudarán a controlar los riesgos de contraer diabetes.	Percepción de riesgo alto Percepción de riesgo moderado Percepción de riesgo bajo	Valoración subjetiva de los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de los adultos, que está influenciada por conocimientos previos, situaciones que involucren a la enfermedad, emociones, factores socioculturales, etc., que se obtendrá mediante una escala de Likert modificada, donde el valor mínimo del enunciado es 1 punto y el máximo 4 puntos. La escala de valoración según máximos y mínimos (ANEXO 6) dan como valores finales en Percepción de riesgo bajo entre 20 y 40 puntos, Percepción de riesgo medio o moderado de 41 a 60 puntos y Percepción de
			Creo que mis hábitos alimenticios (ejemplo: manera de preparar los alimentos, comer ciertos alimentos todos los días, beber agua, etc.) me ayudarán a controlar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus.		
			Creo que mi estilo de vida (actividades que realizo todos los días o como rutina) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.		
			Creo que el nivel de actividad física que realizo (ejemplo: caminar, correr, bailar, etc.) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.		
			Las personas que hacen esfuerzo para controlar los riesgos de contraer diabetes, tienen menos		

			probabilidades de contraer diabetes.		riesgo alto de 61 a 80 puntos.
			Las personas que tiene una alimentación balanceada (alimentarse según peso, edad, sexo y estilo de vida) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.		
			Las personas que no tienen hábitos nocivos (ejemplo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, etc.) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.		
			Siento que tengo poco control sobre los riesgos que podrían existir para mi salud .		
			Siento que tengo poco control sobre el tipo de alimentación que consumo y podría poner en riesgo mi salud.		
			Siento que tengo poco control en hacer la actividad física que podría favorecer mi salud		
			Si voy a tener diabetes, no hay mucho que pueda hacer al respecto.		
			Si me dicen que podría tener diabetes, no está en mis manos mejorar o mantener mi salud.		
		Preocupación	Me preocupa tener diabetes ahora.		
			Me preocupa tener diabetes cuando tenga más de 60 años.		
			Preocuparse por tener diabetes no nos da la solución, es innecesario.		
			Preocuparse por tener diabetes es incómodo y perturbador.		
		Sesgo optimista	En comparación con otras personas de mi edad, tengo menos		

			probabilidades que ellos de tener diabetes.		
			En comparación con otras personas de mi mismo sexo, tengo menos probabilidades que ellos de tener diabetes.		
			En comparación con otras personas de mi edad, tengo menos probabilidad de contraer cualquier enfermedad grave o crónica.		
			En comparación con otras personas de mi mismo sexo, tengo menos probabilidad de contraer una enfermedad grave.		

CAPÍTULO IV: MATERIAL Y MÉTODOS

IV.1. Tipo de estudio y método de investigación

Investigación de naturaleza cuantitativa descriptiva (95), ya que la variable se medirá a través de una escala de Likert modificada y se describirá lo hallado a través del instrumento, de donde se observará los niveles de percepción en la población de manera prospectiva.

IV.2. Diseño de investigación

La investigación es de tipo no experimental de corte transversal (95), ya que los datos se recogerán en un tiempo determinado que será 15 días.

IV.3. Sede de Estudio

El distrito de San Juan de Lurigancho es actualmente considerado el distrito de Cono Este más poblado del Perú con 1 millón 225 mil 92 habitantes en el 2022. La superficie total del distrito es de 131,25 km², lo cual hace que la densidad poblacional sea de 9 mil 340 habitantes/km².

Entre las causas de morbilidad de la población están principalmente: las infecciones de vías respiratorias agudas (35,6%). Caries dental (20,2%) y Obesidad u otros tipos de hiperalimentación (10,1%). Las enfermedades reportadas que permiten evidenciar las causas de mortalidad en la población hasta el 2016, son el un 97,35% por enfermedades no transmisibles, entre las principales se encuentra: IRA, Enfermedad Intersticial y Diabetes Mellitus; mientras que solo 2,65% por enfermedades transmisibles (TBC) (96)

Este distrito cuenta con 23 Centros de Salud y 10 Puestos de Salud del MINSA. El Centro de Salud Zárate es un establecimiento de salud I-3 ubicado en el cruce de Jr. Los Chasquis con Jr. Yupanqui en la Urb. Zárate. Corresponde a la DISA Lima Centro, que ofrece como cartera de servicios a los siguientes: Odontología, Medicina general, Obstetricia,

Enfermería, Psicología, Nutrición, Laboratorio, Farmacia, Estrategia sanitaria de TBC y Adulto mayor. Tiene como objetivo respaldar la integridad de la persona, previniendo enfermedades y favoreciendo la salud, llevando a cabo cada actividad con respeto a la vida y a los derechos humanos en todo el trayecto de vida de la persona, familia y comunidad.

Misión: Lograr que la población asignada a la jurisdicción tenga acceso a los servicios de Salud de Calidad, promocionando la salud, previniendo daños, restableciendo y rehabilitando, apoyando a las familias y articulando a las comunidades e instituciones afines, en la construcción de un entorno saludable.

Visión: En el año 2028 las familias de nuestra jurisdicción estarán sanas, satisfechas recibiendo una atención de calidad de sus amigos servidores de nuestro establecimiento, quienes realizan actividades con la comunidad, logrando entornos saludables y el desarrollo social de la población.

IV4 Población

La población estará conformada por los usuarios y/o pacientes que se atienden en los consultorios del servicio de Medicina general, entre el rango de edad de 18 a 59 años. Tomando en consideración la atención promedio mensual, según el área de Estadística, en ese rango de edad, se estima que en los consultorios de Medicina general se atienden alrededor de 1200 adultos mensualmente, siendo este el número de población del presente constructo para obtener como muestra a 89 personas según la fórmula de población finita. (Anexo 1)

Criterios de Inclusión

- Personas que firman el consentimiento informado.
- Personas que se atienden en los consultorios de Medicina General del Centro de Salud Zárate.
- Personas entre 18 a 59 años.

- Personas con capacidad de leer y escribir.
- Personas con pleno estado de salud mental.

Criterio de Exclusión

- Discapacidad de ver y oír.
- Adultos mayores de 60 años.
- Personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.

IV.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La técnica que se aplicará será la encuesta y como instrumento una escala modificada. Inicialmente la escala Percepción de Riesgo para desarrollar Diabetes (RPS.DD) contaba con 8 enunciados (29), sin embargo, fue extendida para mejor entendimiento de la población, por lo que en la presente investigación se consideró necesario que esté constituido por 20 enunciados sin alterar las tres dimensiones ni indicadores, teniéndose como dimensiones el control interno (7 enunciados) y control externo (5 enunciados), sesgo optimista (4 enunciados) y preocupación (4 enunciados). La escala de Likert modificada, se medirá con la puntuación 1 (muy en desacuerdo), al 4 (Totalmente de acuerdo) con los enunciados de control interno codificados de manera inversa. Los valores más altos en la encuesta darán a conocer más control personal, más preocupación y mayor sesgo optimista, por ende, mayor percepción.

Según la regla de máximos y mínimos, el instrumento tendrá una puntuación según el número de ítems y los valores de cada uno de ellos, siento así que el número de ítems es 20, la Escala Likert mínima será igual 1 punto y el máximo 4 puntos. Los puntajes de valores finales por niveles sería que en percepción de riesgo bajo serán los

que tienen entre 20 a 40 puntos, los de percepción de riesgo medio o moderado entre 41 a 60 puntos y los de percepción de riesgo alto entre 61 a 80 puntos.

La escala modificada será validada por juicio de expertos y la confiabilidad se determinará a partir de los datos de la prueba piloto aplicando el coeficiente de alfa de Cronbach (95) (97).

IV.6. Procedimientos de recolección de datos

Se solicita una resolución de aprobación del proyecto, luego se contará con la aprobación del Comité de ética de la Facultad de Medicina.

La Escuela profesional de Enfermería, emitirá cartas de permisos a nombre de la directora de la DIRIS LIMA CENTRO y a nombre de la Médico jefe del Centro de Salud Zárate para poder aplicar el instrumento aprobado.

Para poder acceder a la población, se solicitará a la DIRIS LIMA CENTRO con los documentos correspondientes, un permiso para acceder y aplicar el instrumento en el C.S. Zárate y posteriormente presentar una solicitud al Centro de Salud Zárate, por medio de la Médico Jefe del establecimiento.

Se aplicará el instrumento a las personas que acepten voluntariamente a participar y que se atiendan en el centro de salud y cumplan con los criterios de inclusión.

Puesto que el instrumento se brindará a cada persona en forma física, los datos se procesarán de manera manual, según el libro de códigos del instrumento.

Una vez obtenido los puntajes directos de cada individuo, será transformado en una base de datos, utilizando el programa Excel, para su posterior análisis en el programa SPSS.

IV.7. Análisis estadístico

Se realizará el análisis estadístico descriptivo y con el objetivo de proporcionar una comprensión clara de la información con los datos recopilados, calcularemos los estadígrafos como las medidas de tendencia central (media o mediana) según la distribución de los datos (análisis de la distribución). Además, se evaluarán los niveles de percepción de riesgo y de proporción, por cada dimensión de riesgo y de forma global; teniendo en cuenta los niveles correspondientes como son: percepción de riesgo bajo, percepción de riesgo medio y percepción de riesgo alto.

Los resultados obtenidos serán presentados mediante tablas y cuadros, que permitirán observar de manera clara y ordenada los análisis estadísticos y los niveles de percepción de la población de estudio.

IV.8. Consideraciones éticas

Se elaboró consentimiento informado, un instrumento o proceso de comunicación que protege y resguarda el derecho y principio bioético de la autonomía, asegurando la dignidad de la persona investigada y total claridad de lo que esta implica (98), pues se presenta el título de la investigación del cuál será partícipe cada paciente o usuario del centro de salud, así mismo se da a conocer la cantidad de enunciados y el tiempo que podría tomarse en contestar todos ellos. Es importante mencionar el objetivo por el cual se realiza el estudio y la participación voluntaria, lo cual resalta el derecho a la libre decisión y opción a no participar si así lo desea (99). Finalmente se brinda el principio de confidencialidad, que guarda y respeta las opiniones, datos personales y resultado final del instrumento de cada individuo que acepta la participación en el presente constructo.

CAPÍTULO V: ADECUACIÓN ADMINISTRATIVA

V1. Cronograma de Gantt.

Actividades	Año 2024							
	Meses							
	Ener	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agost
Elaboración del proyecto	x	x	x					
Aprobación del proyecto (EPE)					x			
Validez y confiabilidad del instrumento			x	x				
Aprobación del Proyecto (DIRIS Lima Centro)						x		
Recolección de datos							x	
Procesamiento y presentación de datos							x	
Resultados y discusión							x	
Conclusiones y recomendaciones								x
Informe final								x
Presentación y sustentación								x

V2 Presupuesto.

Aspecto	Cantidad	Costo por unidad	Total
Bienes			
Hojas bond	1 millar	15.00	15.00
Lapiceros	6	2.00	12.00
Folders	2	9.00	18.00
Engrapadora	1	5.00	5.00
Impresiones	320	0.20	64.40
Copias	100	0.10	10.00
Comida	12	24	288.00
Servicios			
Internet	10 meses	80.00	800.00
Luz	8 meses	50.00	400.00
Transporte	6	24	144.00
Total =			1796.40

V3 Recursos

- Recursos Humanos
 - Un Asesor
 - Un investigador
- Recursos Materiales
 - Hojas
 - Folders
 - Engrapadora
 - Lapiceros
 - Laptop
 - Celular

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ALCOCER BS, VALLE ARC, CEH JGG. Identificación de Factores de Riesgo de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en Adultos de 30 a 60 Años de edad en la Comunidad de Isla Aguada, Municipio de Ciudad del Carmen, Campeche. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo: RIDE. 2015 enero-junio; 5(10).
2. OMS. Organización Mundial de la Salud. [Internet].; 2021 [citado 2022 junio] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>.
3. Leyton. MR. Factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 en población adulta. Barranquilla, Colombia. Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. 2019 mayo; 6(2).
4. Juan Manuel Fabra Heredia LCiM. Relación entre el estilo de vida de un joven deportista de alto rendimiento y los patrones funcionales de salud de Marjory Gordon. 2014 enero.
5. Angélica María Razo González RDCyMPLG. Percepción del estado de salud y la calidad de vida en personas jóvenes, maduras y mayores. CONAMED. 2018; 23(2).
6. Rochefort C, Baldwin AS, Bowen JTyME. Evaluating the validity of the risk perception survey for developing diabetes scale in a safety-net clinic population of English and Spanish speakers. The Diabetes Educator. 2020; 46(1): p. 73-82.
7. OMS. Enfermedades no transmisibles. [Internet].; 2021 [citado 2022 junio] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.
8. Gómez-Peralta F,AC,CX,yGHR. ¿ Cuándo empieza la diabetes? Detección e intervención tempranas en diabetes mellitus tipo 2. Revista Clínica Española. 2020 junio-julio; 220(5).
9. Bernabé-Ortiz RMCLyA. Diabetes mellitus tipo 2 en Perú: una revisión sistemática sobre la prevalencia e incidencia en población general. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica. 2019 enero-marzo; 36(1).
10. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles 2022. Programa Informático de Enfermedades en el Perú. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima; 2023.

11. Yadicelis Llorente Columbié PEMSDR. Factores de riesgo asociados con la aparición de diabetes mellitus tipo 2 en personas adultas. Revista Cubana de Endocrinología. 2016; 27(2).
12. Ana-María Leiva MAMFPAGMFPVXDMCCM. Factores asociados al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en Chile. Nutrición Hospitalaria. 2018 marzo-abril; 35(2).
13. Federación Internacional de Diabetes. Datos y cifras de la Diabetes. [Internet].; 2021 [cited 2023 setiembre 30. Disponible en: <https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/>.
14. De la Rosa J,AM,&SP. Estilos de vida y su influencia en la aparición de complicaciones en la diabetes mellitus tipo 2 en la población de esmeraldas. Ecuador.. Universidad Ciencia y Tecnología. 2018; 22(89).
15. Miryam L, Fátima F, Karen QMyI. Contribuciones médicas para prevenir la diabetes mellitus tipo II. Universidad Ciencia y Tecnología. 2019; 23(95).
16. José Luis Álvarez Suarez FdCADFyMMM. Manual de Valoración de Patrones Funcionales.. Dirección de Enfermería de Atención Primaria.. 2010.
17. Fuenmayor G, Villasmil Y. La percepción, la atención y la memoria como procesos cognitivos utilizados para la comprensión textual. Revista de Artes y Humanidades UNICA. 2008 mayo-agosto; 9(22).
18. Álvarez MVS, González MTGMyEV. La percepción directiva: influencia del perfil cognitivo y de factores contextuales. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. 2011 abril; 14(2).
19. René Rico Sánchez AJLMSPyLdRMA. Nivel de Conocimientos, Estilos de Vida y Control Glicémico en Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. Ene. 2020 abril; 12(1).
20. GUTIERREZ DGQ. TEORÍA DE DOROTHEA OREM- PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA APLICADO AL AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR DIABÉTICO EN EL HB-7 LOJA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 2019.
21. Pelullo CP,RR,NR,NF,yDGG. Prevención de la Diabetes: Conocimiento y Percepción del Riesgo entre la Población Italiana. BioMed Research International. 2019 octubre; 2019.

22. Sánchez BV,RJLB,PEV,CMC,&TGZ. Percepción de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en personas no diabéticas.. Revista de Enfermedades no Transmisibles Finlay. 2016; 6(2).
23. Khan RK,MR,SBS,&WS. Predictores de la percepción del riesgo de diabetes entre estudiantes universitarios. Journal of American College Health. 2020 enero;(1-7).
24. Janet Antwi RLSSyMB. Percepción y factores de riesgo de diabetes tipo 2 entre estudiantes que asisten a una universidad del norte del estado de Nueva York: un estudio piloto. Diabetología y síndrome metabólico (BioMed Central). 2020 marzo; 12(1).
25. Vaja I, Umeh K, Abayomi JC, Newson TPyL. Una teoría fundamentada sobre la prevención de la diabetes tipo 2 y la percepción de riesgos. Revista Británica de Psicología de la Salud (Wiley). 2021; 26(3).
26. Nguyen AP. "Risk perception of developing diabetes: A concept analysis." Nursing Forum. 2020 mayo; 55(4).
27. Lopez-Jaramillo P, Lopez-Lopez J, Cohen DD, Mogollón-Zehr NAA&M. "Epidemiology of hypertension and diabetes mellitus in Latin America.". Current Hypertension Reviews. 2021 enero; 17(2).
28. Rocca J, Calderón M, Rosa AL, Seclén S, Castillo Ó, Pajuelo J, et al. "Type 2 diabetes mellitus in Peru: A literature review including studies at high-altitude settings.". Diabetes Research and Clinical Practice. 2021 noviembre; 182.
29. Catalina Rochefort ASBJTyMEB. Evaluación de la validez de la encuesta de percepción de riesgo para el desarrollo de la escala de diabetes en una población clínica de red de seguridad de habla inglesa y española. The Diabetes Educator. 2020 Noviembre; 46(1).
30. Hsueh L,PJM,HAT,dGM,ySJC. Diabetes risk perception among immigrant and racial/ethnic minority adults in the United States. The Diabetes Educator. 2019 setiembre; 45(6).
31. Ángela Koipuram SCZPyDS. Conocimiento de la diabetes, percepción del riesgo y calidad de vida entre los cuidadores del sur de Asia en la edad adulta joven. BMJ Open Diabetes Research and Care. 2020 noviembre; 8(2).

32. Sulaiman S,LM,&NAW. Risk perception and knowledge regarding diabetes among offspring of type 2 diabetics at a tertiary institution.. The Medical Journal of Malaysia. 2020 noviembre; 75(6).
33. Khlaifat Ali AHLDRySN. Encuesta transversal sobre el conocimiento, las percepciones de riesgo y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes universitarios en el sur de Jordania. Revista de diabetes y trastornos metabólicos (Springer Science and Business Media LLC). 2020 julio; 19(2).
34. Abeer S Alzaben HMB,NIA,AAA,NAANB. La influencia de un programa de concientización sobre la diabetes en el conocimiento, la percepción de riesgos y las prácticas sobre diabetes entre estudiantes universitarios. Primary Care Diabetes. 2023 mayo.
35. Udler PRyMS. Patogenia de la diabetes mellitus tipo 2. 2021 diciembre.
36. Balasubramanyam A. Clasificación de la diabetes mellitus y los síndromes diabéticos genéticos. 2021 diciembre.
37. Khamis AM. "Pathophysiology, Diagnostic Criteria, and Approaches to Type 2 Diabetes Remission.". 2023 Enero; 15(1).
38. Rey-Reñones C, Baena-Díez JM, Aguilar-Palacio I, Grau CM&M. "Type 2 diabetes mellitus and cancer: Epidemiology, physiopathology and prevention." Biomedicines. 2021 Octubre; 19(10).
39. Dumoy JS. Los factores de riesgo. Revista Cubana de Medicina General Integral. 1999 julio-agosto; 15(4).
40. Ana-María Leiva MAMFPAGMFPVXDMyCC. Factores asociados al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en Chile. Nutrición Hospitalaria. 2018 maro - abril; 35(2).
41. Luisa Cecilia Altamirano Cordero MAVC,GCRÁRAJRVB. Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en individuos adultos de la ciudad de Cuenca-Ecuador. Avances en Biomedicina. 2017 abril; 6(1).
42. Cabriales MHMyECG. Riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y sus determinantes. Enfermería Global. 2022 enero-marzo; 21(65).

43. International Diabetes Federation. Atlas de la Diabetes de la FID, novena edición. [Internet].; 2019 [citado 2022 junio 23] Disponible en: https://www.diabetesatlas.org/upload/resources/material/20200302_133352_2406-IDF-ATLAS-SPAN-BOOK.pdf.
44. Shai I, Jiang R, Manson JE, Stampfer MJ, Willett WC, Hu GACyFB. Origen étnico, obesidad y riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres: un estudio de seguimiento de 20 años. Diabetes care. 2006 julio; 29(7).
45. Bancks MP,KK,CAP,GLP,SPJ,yCMR. Association of modifiable risk factors in young adulthood with racial disparity in incident type 2 diabetes during middle adulthood.. 2017 diciembre; 318(24).
46. InterAct Consortium SRLCSSFPRODDvdSYEUKNAEALBBBABI BBBJBHdLGBD. The link between family history and risk of type 2 diabetes is not explained by anthropometric, lifestyle or genetic risk factors: the EPIC-InterAct study. Diabetología. 2013 setiembre; 56(1).
47. Robertson P. Type 2 diabetes mellitus: Prevalence and risk factors. 2022 enero.
48. Vujkovic M, Keaton JM, Lynch JA, Miller DR, Zhou J, Tcheandjieu C, Huffman JE, Assimes TL, Lorenz K, Zhu X, Hilliard AT, Judy RL, Huang J, Lee KM, Klarin D, Pyarajan S, Danesh J , Melander O, Rasheed A, Mallick NH, Hameed S, Qureshi IH, Afzal MN etal. Discovery of 318 new risk loci for type 2 diabetes and related vascular outcomes among 1.4 million participants in a multi-ancestry meta-analysis. Genética de la Naturaleza. 2020 julio; 52(7).
49. Durnwald C. Gestational diabetes mellitus: Screening, diagnosis, and prevention. 2020 julio.
50. Chávez-Courtois M,GC,RPI,SMG,SJB,yPPO. Experiencia y percepciones de la diabetes gestacional y su automanejo en un grupo de mujeres multíparas con sobrepeso.. Ciência & Saúde Coletiva. 2014; 19(6).
51. OMS. Obesidad y Sobrepeso. [Online].; 2021 [cited 2022 agosto 23. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight#:~:text=El%20sobrepeso%20y%20la%20obesidad%20se%20definen%20como%20una%20acumulaci%C3%B3n,la%20obesidad%20en%20los%20adultos>.

52. Teufel F,SJA,GP,TM,MME,EC.&MGJ. Body-mass index and diabetes risk in 57 low-income and middle-income countries: a cross-sectional study of nationally representative, individual-level data in 685 616 adults. The Lancet (Inglaterra). 2021 julio; 398(10296).
53. Andy Menke KFR,JF,YJC,CC. Asociaciones entre tendencias en raza/etnicidad, envejecimiento e índice de masa corporal con prevalencia de diabetes en los Estados Unidos: una serie de estudios transversales. Anales de Medicina Interna. 2014 septiembre; 161(5).
54. Esther Zimmerman 1 LGBMGAAVTISJIP. Childhood body mass index and development of type 2 diabetes throughout adult life-A large-scale danish cohort study. Obesity (Silver Spring). 2017 mayo; 25(5).
55. Organización Mundial de la Salud (OMS). Alimentación sana. [Online].; 2018 [cited 2022 Agosto 25. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>.
56. Evelia Ortiz Contreras LEBEERPRLESEGSBSLI. Frecuencia de “riesgo elevado de desarrollar diabetes” en pacientes de una clínica de medicina familiar. Atención familiar: Órgano de difusión científica del Departamento de Medicina Familiar. 2013; 20(3).
57. Ministerio de Salud y Protección social. ¿Qué es una alimentación saludable? [Online].; 2022 [cited 2022 agosto 25. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/que-es-alimentacion-saludable.aspx>.
58. MIRIAM VF, DIEGO DR, ANAYS AR. Conocimiento del adulto mayor sobre la alimentación balanceada.. In aniversariocimeq2021. 2021 marzo.
59. Ramírez JN. EFECTO DEL CONSUMO DE FIBRA EN LA DIETA DEL PACIENTE DIABÉTICO. REVISTA MEDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA. 2012; 69(600).
60. Guzmán-Pereira MyMLC. "Beneficios de la reducción del consumo de azúcares y aumento de la actividad física en adultos jóvenes con obesidad y la prevención de la diabetes.". Acta Académica. 2020 Noviembre; 67.
61. Hirsch IB. Patient education: Type 2 diabetes: Alcohol, exercise, and medical care (Beyond the Basics). 2019 febrero.

62. Xiang Qian Lao HBD1XLTCZZLYCEKYTTMCSWGNT. Increased leisure-time physical activity associated with lower onset of diabetes in 44 828 adults with impaired fasting glucose: a population-based prospective cohort study. *British Journal of sports medicine*. 2018 enero; 53(14).
63. Ramón Gomis SAPCJVRCyBF. Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes ambulatorios con sobrepeso u obesidad en España. *Estudio OBEDIA. Medicina Clínica*. 2014 junio; 142(11).
64. Petermann F,GMA,DMX,LAM,MM,PVF.&CMC. Tiempo destinado a estar sentado y niveles de adiposidad ¿Cuál es su efecto sobre el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. *Revista Medica de Chile*. 2018 abril; 146(4).
65. Ana Gladys Aráuz Hernández SGPMRA. La circunferencia abdominal como indicador de riesgo de enfermedad cardiovascular. *Acta Médica Costarricense*. 2013 Setiembre ; 55(3).
66. JIMÉNEZ JIMÉNEZ ADySVDC. RELACION DEL PERIMETRO ABDOMINAL Y DIABETES MELLITUS 2. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL. 2015.
67. Richard Giovanni Buendía MZAMAALGDGSVSM. Perímetro de cintura aumentado y riesgo de diabetes. *Acta Médica Colombiana*. 2016 julio - setiembre ; 41(3).
68. Rigotti NA. Patient education: Quitting smoking (Beyond the Basics). 2021 enero.
69. Robertson RP. Prevention of type 2 diabetes mellitus. 2021 octubre.
70. Oviedo GL. LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE PERCEPCIÓN EN PSICOLOGÍA CON BASE EN LA TEORÍA GESTALT. *Revista de Estudios Sociales*. 2004; 18.
71. Kollmann J, Benyamini Y, Renner NCLyB. El papel de la experiencia de riesgo personal: una investigación de la percepción del riesgo de terrorismo y salud en Alemania e Israel. *Risk analysis*. 2022 Agosto; 42(4).
72. Öhman S. "Previous experiences and risk perception: The role of transference.". *Journal of Education, Society and Behavioural Science*. 2017; 23(1).

73. Linden SVd. The social-psychological determinants of climate change risk perceptions: Towards a comprehensive model.". *Journal of Environmental Psychology*. 2015 Marzo; 41.
74. Reyna Cea. "Propiedades psicométricas de las escalas de percepción de riesgo del cambio climático en habitantes de la ciudad de Córdoba, Argentina." *Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento*. 2020 Agosto.
75. Cornejo Aea. Percepción de riesgo, creencias y normas subjetivas de la conducta proambiental en pobladores del sector ladrillero del distrito de San Jerónimo, Cusco, 2019.". *Ambiente, Comportamiento y Sociedad*. 2019; 2.
76. Jhon Alex Zeladita-Huaman ea. "Desarrollo y validación de una escala de percepción de riesgo de COVID-19 en Perú." *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*. 2023 Abril-Junio; 40(2).
77. Shumye M. La percepción del riesgo modera la forma en que el conocimiento se traduce en intenciones de tomar medidas preventivas contra las enfermedades no transmisibles (ENT). 2023 Abril.
78. Vornanen M, Kontinen H, Haukkala MPyA. "Diabetes and Cardiovascular Disease Risk Perception and Risk Indicators: a 5-Year Follow-up.". *International Journal of Behavioral Medicine*. 2021 junio; 28(3).
79. Jizhe Wang YW,ML,LX,XHLXZ. "Risk Perception Scale of Disease Aggravation for older patients with non-communicable diseases: Instrument development and cross-sectional validation study." *Journal of Advanced Nursing*. 2023 Julio.
80. Sağlam FSyHB. "Risk perceptions of patients with type 2 diabetes mellitus regarding insulin therapy and diabetes complications: A cross-sectional study." *Journal of Clinical Nursing*. 2023 Abril.
81. Syahril Yusnaena YMaYDR. Improving Employee Performance Through Perception oh internal locus of control external locus of control at PT. Hayati Padang (A study on motorcycle dealers in Padang City). *Revista Internacional de investigación y revisión*. 2023 mayo; 10(5).

82. Lauren Wadsworth IWCBaTB. Niveles de control percibido y respuesta al tratamiento en un entorno hospitalario parcial breve. *Neurología, Psiquiatría e Investigación del Cerebro* (Elsevier). 2019 diciembre; 1(34).
83. Nowicka-Sauer WRLaK. Percepción de la enfermedad y beneficios percibidos de la enfermedad entre personas con diabetes tipo 1. *Informe Psicología de la Salud*. 2023 noviembre; 11(3).
84. Villota Luna D. Los patrones funcionales de Marjory Gordon y su aplicación en el contexto clínico desde el enfoque de enfermería. 2022 diciembre.
85. Kevin L. Joiner RMSCKJLCYFSLJ. A Spanish-language risk perception survey for developing diabetes: translation process and assessment of psychometric properties. *Journal of nursing measurement*. 2016 diciembre; 24(3).
86. Mónica Arnold Rodríguez YADYAHCVGyTMGC. Pesquisaje y prevención de la diabetes mellitus tipo 2 en población de riesgo. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*. 2012 setiembre - diciembre; 50(3).
87. CABRERA YÁNEZ RA. El impacto emocional en pacientes diabéticos relacionados con el manejo de la enfermedad: Una aproximación bibliográfica. Universidad Tecnológica Indoamérica, Tesis de Licenciatura. 2021.
88. Adrián Marcelo Parra Peralta RLRGIAPÁAOO. La Inteligencia emocional en pacientes miembros de la Fundación Casa de la Diabetes Cuenca, Ecuador. *Revista Cubana de Educación Superior*. 2018 mayo - agosto; 37(2).
89. Seclén S. Diabetes Mellitus en el Perú: hacia dónde vamos. *Revista Medica Herediana*. 2015 enero; 26(1).
90. Aída Jiménez-Corona CAASRRMyMHÁ. Diabetes mellitus tipo 2 y frecuencia de acciones para su prevención y control. *Salud Pública de México*. 2013; 55.
91. Ydalsys Naranjo Hernández JACPyMRL. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. *Gaceta Médica Espirituana*. 2017 setiembre-diciembre; 19(3).

92. Gladis Patricia Aristizábal Hoyos DMBASRRMOM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. Enfermería Universitaria. 2011 octubre-diciembre; 8(4).
93. Ngwazini C. Implementación del "Plan de evaluación clínica para la promoción de la salud" de Nola Pender para aumentar la autoeficacia del paciente, la pérdida de peso y los comportamientos que promueven la salud". 2022 mayo.
94. Daniela Bulcão Santi ISN,VADB. Modelo de Nola Pender para promoción de la salud adolescente. 2023 abril; 27.
95. Mendoza RHSyC. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: LAS RUTAS CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y MIXTA McGraw-hill , editor.; 2020.
96. Rafael Wilfredo Medina Yancán MCL&YVB. ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO. MINSA-DIRIS Lima Centro. 2019 Noviembre.
97. Meza HHSC&CR. METODOLOGÍA Y DISEÑOS EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Quinta ed. Lima: Business Support Aneth; 2017.
98. Sandú A. El Consentimiento Informado - Como Herramienta Protectora del Derecho a la Autonomía y a la Dignidad de los Sujetos Humanos que Participan en Investigaciones Biomédicas, en el Contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Jurnalul de studii juridice. 2022 Marzo; 16(3).
99. Delphine Eeckhout KA,CVDS. Consentimiento informado: perspectivas del personal de investigación y recomendaciones prácticas para mejorar la comunicación entre el personal de investigación y los participantes. Revista de investigación empírica sobre ética de la investigación humana. 2022 diciembre; 18(1).
100. ERIKSON EH. Estadios fundamentales del desarrollo psicosocial. En El ciclo vital completado.; 1985.
101. Martínez RMF. Vejez, violencia y dependencia: un análisis desde los aspectos jurídicos de. Revista de Temas Sociales. 2018 noviembre; 42(3).

102. INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática. [Online].; 2020 [cited 2022 junio 1. Available from: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-399-de-peruanos-de-15-y-mas-anos-de-edad-tiene-al-menos-una-comorbilidad-12903/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202020%2C%20el%204%2C5%25%20de%20la,hombres%20al%204%2C1%25.>
103. INEI DCB. Situación de la población Adulta Mayor. Informe Técnico. Lima: INEI, Lima; 2022.
104. Rodríguez-Laso Á,MMÁC,SIG,BCA,MLR,&BR. Updated state of the art report on the prevention and management of frailty. Joint Action. agosto del 2019.
105. Lizeth I. Chuquipoma-Quispe JELVJADICV. Factores asociados al síndrome de fragilidad en adultos mayores que acuden a consulta externa de Geriatria del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima-Perú. Acta Médica Peruana. 2019 octubre-diciembre; 36(4).
106. Erick Acosta-Illatopa JLVFGS. SÍNDROME DE FRAGILIDAD EN ADULTOS MAYORES DE UNA COMUNIDAD RURAL DE LOS ANDES PERUANOS. Revista de la Facultad de Medicina Humana. 2021 abril; 21(2).
107. Karla Berenice Carrazco-Peña KFMBTHIDE. Frecuencia de fragilidad y comorbilidad en adultos mayores. Revista Argentina de Gerontología y Geriatria. 2019 julio; 33(2).
108. Esquinas-Requena JL, Lozoya-Moreno S, García-Nogueras I, Atienzar-Núñez P, Sánchez-Jurado PM, Abizanda P. La anemia aumenta el riesgo de mortalidad debido a fragilidad y discapacidad en mayores: Estudio FRADEA. Atención Primaria. 2020 agosto-setiembre; 52(7).
109. Kim C MLPJGJFAWE. Risk perception for diabetes among women with histories of gestational diabetes mellitus.. Diabetes Care. 2007 junio; 30(9).
110. Rosenda Murillo BJKTGIVySE. La asociación de la percepción del riesgo de prediabetes y diabetes con la actividad física en el tiempo libre y la pérdida de peso. American Journal of Health Promotion. 2019 mayo; 33(4).

111. Sánchez BV,RJLB,PEV,CMC,yTGZ. Percepción de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en personas no diabéticas.. Revista de Enfermedades no Transmisibles Finlay. 2016 abril-junio; 6(2).
112. Manas FFyLR. Diabetes mellitus tipo 2 en el anciano, nueva evidencia para aplicar el conocimiento a la práctica clínica diaria. Revista Española de Geriatria y Gerontología. 2013; 48(2).
113. Simmons S. Risk Perceptions for Type 2 Diabetes Mellitus Among College Students. 2018 mayo.

ANEXOS

ANEXO 1: Fórmula de población finita

$$n = Z_{\alpha}^2 \frac{N \cdot p \cdot q}{i^2 (N - 1) + Z_{\alpha}^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

- **n** = Tamaño muestral
- **N** = Tamaño de la población, número total de elementos de la población.
- **Z** = Valor encontrado en la tabla de la distribución Normal, 1.96 para $\alpha = 0.05$ y
- **p** = Proporción esperada de la característica a evaluar. En caso de desconocerse, aplicar la opción más favorable ($p=0,5$), que hace mayor el tamaño muestral.
- **q** = $1-p = 0,5$
- “**i**” o “**d**” Error que se comete al escoger la muestra, para $\alpha = 0.05$ es un **i** = **0.1**

Población adultos jóvenes

$$n = \frac{3,8416 \times 1200 \times 0,5 \times 0,5}{0,01 \times (1199) + 3,8416 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$n = \frac{1152,48}{11,99 + 0,9604}$$

$$n = \frac{1152,48}{12,9504} = > \quad \mathbf{n = 88,9}$$

ANEXO 2: Matriz de consistencia del proyecto de investigación

“Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024”

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE	METODOLOGÍA	POBLACIÓN Y MUESTRA
General: ¿Cuál es la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024?	GENERAL: - Determinar percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho, 2024 ESPECÍFICOS - Identificar percepción de riesgo en la dimensión control personal interno y externo que tienen los adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho - Identificar percepción de riesgo en la dimensión preocupación que tienen los adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho - Identificar percepción de riesgo en la dimensión sesgo optimista que tienen los adultos maduros que acuden a un centro de salud de San Juan de Lurigancho	No requiere hipótesis, por ser un estudio descriptivo.	Percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Impresión y estimación subjetiva de un estímulo determinado que se interpreta en base a conocimientos previos, ideas, pensamientos, etc., acerca de los factores de riesgo, modificable y no modificables, de la enfermedad Diabetes Mellitus tipo 2. DEFINICIÓN OPERACIONAL: Valoración subjetiva de los factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2 de los adultos, que está influenciada por conocimientos previos, situaciones que involucren a la enfermedad, emociones, factores socioculturales, etc., que se obtendrá mediante una escala de Likert modificada, donde el valor mínimo del enunciado es 1 punto y el valor máximo 4 puntos. La escala de valoración según máximos y mínimos dan como valores finales en, Percepción de riesgo bajo de entre 20 a 40 puntos, Percepción de riesgo medio o moderado de 41 a 60 puntos y Percepción de riesgo alto de 61 a 80 puntos.	TIPO DE INVESTIGACIÓN: Cuantitativa descriptiva de corte transversal. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No experimental.	POBLACIÓN: Usuarios y/o pacientes que se atienden en el servicio de Medicina general, donde en un turno de 6 horas, en promedio se atienden 6 adultos entre 18 y 59 años, lo que quiere decir que al mes se atienden 288 pacientes de esa edad en un consultorio, teniendo en cuenta que el centro de salud atiende 12 horas al día y se laboran 6 días a la semana y son 5 consultorios de medicina general, para la fórmula de población finita se tendrá como población 1440 personas. MUESTRA Por fórmula de población finita, se obtuvo que la muestra debe ser mínimamente 93 personas. (ANEXO 1)

ANEXO 3: Consentimiento Informado

Estimado usuario, soy Gianella Lezameta Estacio, Bachiller de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Escuela de Enfermería, les presento el siguiente estudio titulado PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADULTOS MADUROS QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE LIRUGANCHO, 2024 que tiene como objetivo determinar la percepción de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2, para lo cual la información que usted brinde será importante y se manejará de manera confidencial.

Su participación es de manera voluntaria y consiste en responder la siguiente escala de Likert modificada que consta de 20 enunciados, lo que le tomará alrededor de 15 minutos poder contestar toda la escala, así mismo resaltar que los datos estarán bajo anonimato y confidencialidad.

¿Desea participar en el presente estudio?

Sí ☐ No ☐

Se agradece su participación

ANEXO 4: Validación de instrumento

Claridad

ÍTEMS	J1	J2	J3	Σ	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	4	3	5	12	4	1	0.037	0.963
2	4	3	5	12	4	1	0.037	0.963
3	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
4	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
5	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
6	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
7	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
8	3	3	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
9	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
10	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
11	4	1	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
12	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
13	4	2	5	11	3.6666667	0.9166667	0.037	0.8796667
14	4	1	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
15	3	2	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
16	3	2	5	10	3.3333333	0.8333333	0.037	0.7963333
17	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
18	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
19	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
20	2	2	5	9	3	0.75	0.037	0.713
							Σ	16.76
							N° Ítems	20
							CVCt	0.838
							CVC	0.801

Relevancia

ÍTEMS	J1	J2	J3	Σ	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	4	2	5	11	3.667	0.917	0.037	0.880
2	4	3	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
3	4	1	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
4	4	1	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
5	4	4	5	13	4.333	1.083	0.037	1.046
6	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
7	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
8	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
9	5	4	5	14	4.667	1.167	0.037	1.130
10	5	3	5	13	4.333	1.083	0.037	1.046
11	5	1	5	11	3.667	0.917	0.037	0.880
12	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
13	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
14	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
15	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
16	5	2	5	12	4.000	1.000	0.037	0.963
17	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
18	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
19	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
20	3	2	5	10	3.333	0.833	0.037	0.796
							Σ	18.926
							N° Ítems	20
							CVCt	0.9462963
							CVC	0.909

ANEXO 5: Escala de Likert de Percepción de Riesgo de la Diabetes Mellitus tipo 2

Instrumento del Proyecto de Investigación: PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EN ADULTOS MADUROS QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2024

Fecha: ____/____/____

Código

Presentación

Estimados usuarios, soy Bachiller de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estoy realizando un estudio que tiene como objetivo determinar la percepción de riesgo de la diabetes mellitus en adultos maduros que acuden a un centro de salud de san Juan de Lurigancho, 2024, para lo cual solicito su colaboración para responder con la mayor sinceridad, así mismo señalar que la información que proporcionará es anónima y se utilizará con fines académicos.

Agradezco de antemano su colaboración

Instrucciones



- Llene y lea detenidamente las preguntas del bloque Datos generales y marque (X) una de las opciones o escriba la respuesta



- Marque solo una respuesta

Datos Generales

1. ¿Cuántos años tiene? años
2. Sexo:
☐ Femenino ☐ Masculino
3. Grado de instrucción alcanzado
☐ Primaria
☐ Secundaria
☐ Educación superior técnica
☐ Educación superior universitaria
4. Estado civil
☐ Casado ☐ Soltero ☐ Conviviente ☐ Viudo/Divorciado
5. ¿Ha tenido o tiene parientes (padres, tíos o abuelos) con diabetes mellitus tipo 2?
☐ Sí ☐ No
6. ¿Ha tenido o tiene alguna de las siguientes enfermedades?
☐ Hipertensión arterial

- ☐ Obesidad
- ☐ Otro (Especifique): _____

7. Qué seguro de salud tiene actualmente vigente

- ☐ SIS
- ☐ EsSalud
- ☐ Otro

Escala de Likert de la Percepción de Riesgo de la Diabetes



- Lea detenidamente y marque con un aspa (X) la respuesta que considere



- Solo debe marcar un recuadro por enunciado

Contenido

Enunciados	Muy en desacuerdo	En Desacuerdo	De Acuerdo	Muy de acuerdo
1. En comparación con otras personas de mi edad, tengo menos probabilidades que ellos de tener diabetes.				
2. En comparación con otras personas de mi mismo sexo, tengo menos probabilidades que ellos de tener diabetes.				
3. En comparación con otras personas de mi edad, tengo menos probabilidad de contraer cualquier enfermedad grave o crónica.				
4. En comparación con otras personas de mi mismo sexo, tengo menos probabilidad de contraer una enfermedad grave.				
5. Creo que mis esfuerzos personales (ejem: ir al médico, priorizar mi salud, etc.) me ayudarán a controlar los riesgos de contraer diabetes.				
6. Creo que mis hábitos alimenticios (ejemplo: manera de preparar los alimentos, comer ciertos alimentos todos los días, beber agua, etc.) me ayudarán a controlar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus.				
7. Creo que mi estilo de vida (actividades que realizo todos los días o				

como rutina) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.				
8. Creo que el nivel de actividad física que realizo (ejemplo: caminar, correr, bailar, etc.) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.				
9. Las personas que hacen esfuerzo para controlar los riesgos de contraer diabetes, tienen menos probabilidades de contraer diabetes.				
10. Las personas que tiene una alimentación balanceada (alimentarse según peso, edad, sexo y estilo de vida) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.				
11. Las personas que no tienen hábitos nocivos (ejemplo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, etc.) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.				
12. Siento que tengo poco control sobre los riesgos que podrían existir para mi salud .				
13. Siento que tengo poco control sobre el tipo de alimentación que consumo y podría poner en riesgo mi salud.				
14. Siento que tengo poco control en hacer la actividad física que podría favorecer mi salud				
15. Si voy a tener diabetes, no hay mucho que pueda hacer al respecto.				
16. Si me dicen que podría tener diabetes, no está en mis manos mejorar o mantener mi salud.				
17. Me preocupa tener diabetes ahora.				
18. Me preocupa tener diabetes cuando tenga más de 60 años.				
19. Preocuparse por tener diabetes no nos da la solución, es innecesario.				
20. Preocuparse por tener diabetes es incómodo y perturbador.				

ANEXO 5: Libro de códigos

Datos generales

Edad	
Sexo	1. Femenino
	2. Masculino
Grado de instrucción alcanzado	1. Primaria
	2. Secundaria
	3. Educación superior técnica
	4. Educación superior universitaria
Estado civil	1. Casado
	2. Soltero
	3. Conviviente
	4. Viudo / divorciado
¿Ha tenido o tiene parientes (padres, tíos o abuelos) con diabetes mellitus tipo 2?	1. Sí
	2. No
¿Ha tenido o tiene alguna de las siguientes enfermedades?	1. Hipertensión arterial
	2. Obesidad
	3. Otro
¿Qué seguro de salud tiene actualmente vigente?	1. SIS
	2. EsSalud
	3. Otro

Contenido

Enunciados	Totalmente desacuerdo	En Desacuerdo	De Acuerdo	Totalmente de acuerdo
Sesgo Optimista				
1. En comparación con otras personas de mi edad, tengo menos probabilidades que ellos de tener diabetes.	1	2	3	4
2. En comparación con otras personas de mi mismo sexo, tengo menos probabilidades que ellos de tener diabetes.	1	2	3	4
3. En comparación con otras personas de mi edad, tengo menos probabilidad de contraer cualquier enfermedad grave o crónica.	1	2	3	4
4. En comparación con otras personas de mi mismo sexo, tengo menos probabilidad de contraer una enfermedad grave.	1	2	3	4
Control interno				
5. Creo que mis esfuerzos personales (ejem: ir al médico, priorizar mi salud, etc.) me ayudarán a controlar los riesgos de contraer diabetes.	4	3	2	1
6. Creo que mis hábitos alimenticios (ejemplo: manera de preparar los alimentos, comer ciertos alimentos todos los días, beber agua, etc.) me ayudarán a controlar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus.	4	3	2	1
7. Creo que mi estilo de vida (actividades que realizo todos los días o como rutina) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.	4	3	2	1
8. Creo que el nivel de actividad física que realizo (ejemplo: caminar, correr, bailar, etc.) me ayudará a controlar el riesgo de contraer diabetes mellitus tipo 2.	4	3	2	1

9. Las personas que hacen esfuerzo para controlar los riesgos de contraer diabetes, tienen menos probabilidades de contraer diabetes.	4	3	2	1
10. Las personas que tiene una alimentación balanceada (alimentarse según peso, edad, sexo y estilo de vida) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.	4	3	2	1
11. Las personas que no tienen hábitos nocivos (ejemplo: fumar, tomar bebidas alcohólicas, etc.) tienen menos probabilidades de contraer diabetes.	4	3	2	1
Control externo				
12. Siento que tengo poco control sobre los riesgos que podrían existir para mi salud.	1	2	3	4
13. Siento que tengo poco control sobre el tipo de alimentación que consumo y podría poner en riesgo mi salud.	1	2	3	4
14. Siento que tengo poco control en hacer la actividad física que podría favorecer mi salud	1	2	3	4
15. Si voy a tener diabetes, no hay mucho que pueda hacer al respecto.	1	2	3	4
16. Si me dicen que podría tener diabetes, no está en mis manos mejorar o mantener mi salud.	1	2	3	4
Preocupación				
17. Me preocupa tener diabetes ahora.	1	2	3	4
18. Me preocupa tener diabetes cuando tenga más de 60 años.	1	2	3	4
19. Preocuparse por tener diabetes no nos da la solución, es innecesario.	1	2	3	4
20. Preocuparse por tener diabetes es incómodo y perturbador.	1	2	3	4